

Matriz Pericial de Causalidade Psiquiátrica Forense

Aplicação: pareceres e laudos em psiquiatria forense, especialmente nexo causal/concausalidade, dano psíquico, transtornos mentais relacionados ao trabalho, burnout, assédio moral, incapacidade laboral e agravamento de transtorno prévio.

Base metodológica: Bradford Hill; Rothman & Greenland; psiquiatria forense brasileira; medicina legal; epidemiologia causal; avaliação clínica longitudinal.

Este instrumento não substitui o juízo médico-pericial. Deve ser aplicado caso a caso, com base nos autos, documentos médicos, exame psíquico, funcionalidade e coerência clínico-documental.

1. Princípio central

Em psiquiatria forense, a causalidade raramente é única, linear e suficiente. Transtornos mentais costumam decorrer da interação entre vulnerabilidades individuais, fatores biográficos, predisposição familiar, eventos traumáticos, condições laborais, suporte social, comorbidades clínicas, uso de substâncias, personalidade prévia e fatores de manutenção.

Portanto, a pergunta pericial não deve ser apenas:

“O evento X causou sozinho o transtorno mental?”

Mas sim:

“O evento, exposição ou condição investigada participou de modo clinicamente e juridicamente relevante do desencadeamento, agravamento, manutenção ou recidiva do quadro psíquico?”

Essa formulação é mais adequada para a análise de **nexo causal**, **concausalidade**, **agravamento**, **dano psíquico** e **incapacidade laboral**.

2. Matriz principal de análise causal

Eixo	Pergunta pericial	Evidência que fortalece	Evidência que enfraquece
1. Temporalidade	A exposição/evento antecedeu o início ou agravamento?	Sintomas surgem após evento; piora após exposição; documentação contemporânea	Sintomas claramente anteriores e estáveis; evento posterior ao quadro
2. Plausibilidade psicopatológica	O tipo de exposição é compatível com o transtorno?	Trauma → TEPT; humilhação crônica/sobrecarga → ansiedade/depressão/burnout	Exposição pouco compatível com sintomas; narrativa vaga ou inespecífica

3. Intensidade e duração	A exposição teve intensidade suficiente?	Reiteração, duração prolongada, sobrecarga, ameaça, violência psicológica	Evento leve, isolado, sem repercussão funcional demonstrada
4. Gradiente clínico	Houve piora proporcional à exposição?	Sintomas aumentam com intensificação da exposição; piora progressiva	Evolução sem relação com variação da exposição
5. Reversibilidade	Houve melhora ao afastar e piora ao retornar?	Melhora em afastamento; recaída com reexposição ou iminência de retorno	Sem mudança com afastamento; piora apesar da cessação completa por outros motivos
6. Coerência documental	Documentos sustentam a cronologia?	Prontuários, atestados, CAT, comunicações, relatórios contemporâneos	Documentos tardios, contraditórios ou apenas retrospectivos
7. Consistência clínica	Relato, exame psíquico e funcionalidade convergem?	Sintomas compatíveis; prejuízo funcional observável; evolução congruente	Inconsistências graves; discrepância marcada entre queixa e funcionamento
8. Antecedentes	Havia transtorno prévio?	Ausência prévia ou mudança clara de patamar após exposição	Quadro prévio grave, recorrente e independente da exposição
9. Hipóteses alternativas	Há causa alternativa mais provável?	Alternativas ausentes ou insuficientes para explicar o quadro	Luto, uso de substâncias, doença clínica, conflito familiar ou evolução natural explicam melhor
10. Funcionalidade	Houve prejuízo real na capacidade?	Queda laboral/social, afastamentos, perda de desempenho, isolamento	Funcionamento preservado sem limitação objetiva relevante
11. Tratamento e evolução	Evolução terapêutica é compatível?	Necessidade de tratamento, medicação, psicoterapia, internação, refratariedade	Ausência de tratamento sem justificativa; evolução incompatível
12. Simulação/dissimulação	Há indicadores de produção voluntária ou exagero?	Inconsistências, incompatibilidade clínica, ganhos externos intensos, testes/observação sugestivos	Relato consistente, sofrimento observado, documentação independente

3. Escala de força da inferência causal

Grau 0 — Nexo não sustentado

Não há elementos suficientes de temporalidade, plausibilidade, coerência documental ou consistência clínica. A exposição/evento não se mostra tecnicamente relacionada ao quadro psíquico, ou há explicação alternativa mais provável.

Formulação útil:

Os elementos disponíveis não sustentam nexos causal ou concausalidade entre o evento/exposição investigado e o quadro psíquico descrito, seja por ausência de temporalidade adequada, insuficiência documental, inconsistência clínico-funcional ou presença de hipótese alternativa mais provável.

Grau 1 — Nexos possível

Há alguma compatibilidade temporal ou narrativa, mas faltam elementos objetivos, documentação contemporânea, coerência longitudinal ou demonstração funcional suficiente.

Formulação útil:

A hipótese de relação entre o evento/exposição e o quadro psíquico é possível, porém não suficientemente demonstrada do ponto de vista técnico-pericial. Os dados disponíveis permitem cogitar associação temporal, mas não autorizam conclusão segura de nexos causal ou concausalidade relevante.

Grau 2 — Concausalidade possível/provável

Há transtorno prévio, vulnerabilidade pessoal ou fatores extralaborais, mas a exposição investigada parece ter contribuído para agravamento, recidiva, mudança de patamar sintomático ou prejuízo funcional adicional.

Formulação útil:

Considerando a natureza multifatorial dos transtornos mentais, os elementos analisados são compatíveis com participação concausal da exposição investigada, especialmente como fator de agravamento, recidiva ou manutenção do quadro, sem que isso implique causalidade única ou exclusiva.

Grau 3 — Nexos provável

Há temporalidade adequada, plausibilidade psicopatológica, coerência documental, consistência clínica e ausência de hipótese alternativa mais convincente.

Formulação útil:

O conjunto dos elementos clínicos, documentais e cronológicos torna mais provável do que não provável a existência de nexos causal entre a exposição/evento investigado e o quadro psíquico apresentado, observadas as limitações inerentes à inferência causal em psiquiatria forense.

Grau 4 — Nexos fortemente sustentado

Há documentação contemporânea robusta, exposição intensa, cronologia clara, evolução longitudinal compatível, melhora com afastamento, piora à reexposição, prejuízo funcional demonstrado e hipóteses

alternativas pouco plausíveis.

Formulação útil:

A inferência de nexo causal encontra-se fortemente sustentada pela convergência entre temporalidade, plausibilidade psicopatológica, coerência documental, evolução longitudinal, repercussão funcional e ausência de explicação alternativa mais provável.

4. Bradford Hill adaptado à psiquiatria forense

Ponto de vista de Hill	Tradução para saúde mental/perícia	Observação técnica
Força	Intensidade da associação clínica entre exposição e sintomas	Em psiquiatria, força não é apenas risco relativo; inclui magnitude funcional e mudança de patamar
Consistência	Repetição do padrão em documentos, relatos, evolução e fontes independentes	Consistência não exige relatos idênticos; exige convergência global
Especificidade	Compatibilidade entre tipo de exposição e tipo de desfecho	Especificidade é limitada em psiquiatria; um mesmo estressor pode gerar quadros diversos
Temporalidade	Exposição precede início, agravamento ou recidiva	É o critério mais indispensável
Gradiente biológico	Maior exposição/intensidade/duração → piora clínica ou funcional	Pode ser clínico-longitudinal, não laboratorial
Plausibilidade	Mecanismo psicopatológico compreensível	Estresse crônico, trauma, humilhação, ameaça, perda de autonomia, privação de sono etc.
Coerência	Hipótese não conflita com curso clínico, documentos e exame psíquico	Exige integração entre autos e clínica
Experimento	Melhora com afastamento e piora com reexposição	Deve ser interpretado com cautela; não prova isoladamente
Analogia	Casos ou fenômenos semelhantes reconhecidos na literatura	Útil em burnout, TEPT, assédio moral, violência ocupacional

5. Checklist antes de concluir nexo/concausalidade

Antes de afirmar nexo causal, concausalidade ou agravamento, verificar:

- ☐ Há diagnóstico psiquiátrico ou síndrome clínica bem descrita?
- ☐ O diagnóstico está separado da conclusão jurídico-pericial?
- ☐ A exposição/evento está claramente descrita?
- ☐ Há cronologia mínima confiável?
- ☐ Os sintomas começaram, pioraram ou recidivaram após a exposição?

- ☐ Há documentação contemporânea aos fatos?
- ☐ O exame psíquico é compatível com a queixa?
- ☐ Há prejuízo funcional demonstrável?
- ☐ Há antecedentes psiquiátricos? Se sim, houve mudança de patamar?
- ☐ Há fatores extralaborais ou alternativos relevantes?
- ☐ Esses fatores alternativos explicam melhor o quadro?
- ☐ Houve melhora com afastamento?
- ☐ Houve piora com reexposição ou expectativa de retorno?
- ☐ Há consistência entre relato, documentos, evolução e funcionalidade?
- ☐ Foram consideradas simulação, dissimulação ou agravamento voluntário quando pertinente?
- ☐ A conclusão está proporcional à força da evidência?

6. Separação obrigatória: diagnóstico, nexos, dano e incapacidade

Para laudo robusto, recomenda-se separar quatro perguntas:

6.1 Diagnóstico

Existe transtorno mental atual ou pretérito? Qual a síndrome, gravidade, curso e tratamento?

6.2 Nexos causal/concausalidade

O evento ou exposição investigada participou do início, agravamento, manutenção ou recidiva do quadro?

6.3 Dano psíquico

Houve repercussão psíquica juridicamente relevante, persistente ou significativa, além de sofrimento transitório comum?

6.4 Incapacidade

Há limitação funcional atual para a atividade habitual ou para atividades laborais em geral? A incapacidade é temporária ou permanente, parcial ou total?

Frase útil:

Diagnóstico psiquiátrico, nexos causal, dano psíquico e incapacidade laboral são categorias relacionadas, porém distintas. A presença de uma não implica automaticamente a presença das demais.

7. Argumentos comuns e respostas técnico-periciais

7.1 “O periciando já tinha transtorno antes”

A existência de antecedente psiquiátrico não exclui nexo ou concausalidade. Deve-se avaliar se houve agravamento, recidiva, mudança de patamar sintomático, piora funcional ou necessidade terapêutica adicional após o evento/exposição.

Texto para parecer:

Antecedentes psiquiátricos representam fator de vulnerabilidade, mas não afastam automaticamente a possibilidade de participação concausal do evento investigado. A análise pericial deve verificar se houve alteração clinicamente relevante do curso anterior da doença.

7.2 “Não há exame objetivo que prove”

Em psiquiatria, a ausência de marcador laboratorial específico não elimina a possibilidade de diagnóstico ou nexo. A robustez decorre da convergência entre história clínica, exame psíquico, documentação, funcionalidade e evolução longitudinal.

Texto para parecer:

A inexistência de marcador biológico específico não impede a inferência psiquiátrico-forense, desde que a conclusão esteja sustentada por dados clínicos, documentais, cronológicos e funcionais convergentes.

7.3 “Existem problemas familiares/financeiros”

Fatores extralaborais podem coexistir com fatores laborais. A presença de múltiplos fatores exige análise de peso relativo, e não exclusão automática do nexo.

Texto para parecer:

A presença de fatores psicossociais extralaborais não exclui, por si só, a participação causal ou concausal da exposição investigada, devendo-se avaliar qual hipótese explica melhor a evolução clínica global.

7.4 “Melhorou afastado porque não queria trabalhar”

Essa hipótese deve ser considerada, mas não presumida. A melhora com afastamento e piora com reexposição podem ter valor semiológico quando acompanhadas de documentação clínica, coerência funcional e plausibilidade psicopatológica.

Texto para parecer:

O padrão de melhora durante afastamento e reagudização diante da reexposição ou expectativa de retorno deve ser analisado criticamente, pois pode refletir tanto alívio inespecífico quanto

reversibilidade relacionada ao agente estressor. Seu valor aumenta quando há coerência documental e evolução clínica compatível.

7.5 “Assédio moral não está provado”

O perito psiquiatra não deve substituir o juízo na prova do assédio. Deve avaliar se os fatos narrados, se juridicamente reconhecidos, são compatíveis com o quadro clínico e se há repercussão psíquica.

Texto para parecer:

A caracterização jurídica do assédio moral compete ao juízo. Do ponto de vista médico-pericial, analisa-se a compatibilidade entre os eventos descritos/documentados, a evolução psicopatológica e a repercussão funcional observada.

7.6 “Burnout é inespecífico”

Burnout exige relação contextual com estressores ocupacionais crônicos, mas deve ser diferenciado de depressão maior, transtornos ansiosos, transtorno de adaptação, uso de substâncias e condições clínicas.

Texto para parecer:

A hipótese de burnout deve ser examinada à luz da exposição ocupacional crônica, do esgotamento relacionado ao trabalho, da redução de eficácia profissional e do distanciamento ou cinismo em relação ao trabalho, sem dispensar diagnóstico diferencial com outros transtornos mentais.

8. Blocos prontos de conclusão

8.1 Conclusão favorável a concausalidade

À luz dos elementos analisados, o quadro psíquico apresenta natureza multifatorial, havendo fatores pessoais e contextuais que devem ser considerados. Ainda assim, a exposição investigada mostra compatibilidade temporal, plausibilidade psicopatológica e coerência clínico-documental suficientes para ser considerada concausa relevante, especialmente em relação ao agravamento e à manutenção dos sintomas observados.

8.2 Conclusão favorável a nexó provável

O conjunto probatório médico-pericial aponta para nexó causal provável entre a exposição/evento investigado e o quadro psiquiátrico, considerando a sequência temporal, a natureza da exposição, a evolução clínica, a repercussão funcional e a ausência de hipótese alternativa mais convincente.

8.3 Conclusão contrária ao nexó

Os elementos disponíveis não permitem sustentar nexó causal ou concausalidade relevante entre a exposição/evento investigado e o quadro psiquiátrico. A conclusão decorre da insuficiência de temporalidade, da fragilidade documental, da inconsistência clínico-funcional e/ou da presença de fatores alternativos mais aptos a explicar a evolução observada.

8.4 Conclusão inconclusiva

Os dados disponíveis são insuficientes para conclusão técnico-pericial segura quanto ao nexó causal. Recomenda-se cautela interpretativa, pois a documentação apresentada não permite reconstrução cronológica adequada nem avaliação robusta das hipóteses causais concorrentes.

9. Estrutura recomendada para discussão de nexó em laudo

1. Diagnóstico psiquiátrico atual e/ou pretérito.
2. História clínica anterior ao evento/exposição.
3. Descrição objetiva da exposição/evento investigado.
4. Cronologia de sintomas e tratamentos.
5. Análise dos antecedentes e vulnerabilidades.
6. Análise de hipóteses alternativas.
7. Aplicação da matriz causal.
8. Discussão de funcionalidade/incapacidade, separada do nexó.
9. Conclusão graduada: ausente, possível, provável, concausal, agravamento ou inconclusiva.

10. Mini-quadro para inserir no parecer

Dimensão	Achado do caso	Peso pericial
Temporalidade	[INSERIR]	Favorável / neutro / desfavorável
Plausibilidade	[INSERIR]	Favorável / neutro / desfavorável
Intensidade/duração	[INSERIR]	Favorável / neutro / desfavorável
Reversibilidade	[INSERIR]	Favorável / neutro / desfavorável
Documentação	[INSERIR]	Favorável / neutro / desfavorável
Funcionalidade	[INSERIR]	Favorável / neutro / desfavorável
Antecedentes	[INSERIR]	Favorável / neutro / desfavorável
Hipóteses alternativas	[INSERIR]	Favorável / neutro / desfavorável
Consistência global	[INSERIR]	Favorável / neutro / desfavorável

11. Referências de apoio

- Abdalla-Filho E, Chalub M, Telles LEB. **Psiquiatria Forense de Taborda**. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2016.
 - Taborda JGV, Chalub M, Abdalla-Filho E. **Psiquiatria Forense**. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed; 2012.
 - Palomba GA. **Tratado de Psiquiatria Forense Civil e Penal**. São Paulo: Atheneu; 2003.
 - França GV. **Medicina Legal**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
 - Hill AB. The environment and disease: association or causation? **Proc R Soc Med**. 1965;58:295-300.
 - Rothman KJ, Greenland S. Causation and causal inference in epidemiology. **Am J Public Health**. 2005;95 Suppl 1:S144-S150.
 - Rothman KJ, Greenland S, Lash TL. **Modern Epidemiology**. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008.
-

12. Nota final de prudência

A robustez do laudo não decorre de afirmar com excesso de certeza, mas de explicitar método, limites, hipóteses alternativas e grau de inferência. Em psiquiatria forense, conclusões bem graduadas tendem a ser mais defensáveis do que afirmações categóricas sem lastro documental e psicopatológico.